Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Alvorada

Rua Contabilista Vitor Brum, s/n, Parada 48 - Bairro: Maringá - CEP: 94814-595 - Fone: (51) 3098-3389 - www.tjrs.jus.br - Balcão virtual: (51) 99990-1715 - Email: fralvorada2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5010058-06.2023.8.21.0003/RS

AUTOR: CATIA SILENE GOMES

AUTOR: JOANA GOMES PIUCCO

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RÉU: MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

JOANA GOMES PIUCCO ajuizou a presente *ação ordinária com pedido de antecipação de tutela*, em face de **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e **MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS**, ambos já qualificados na inicial. Aduziu, em síntese, que possui *diagnóstico de osteoporose pósmenopáusica e esclerose sistêmica*, patologia registrada junto à Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à saúde sob o *código CID10 M810 e CID10 M34.* Esclareceu que, para tratamento da referida enfermidade, necessita de forma urgente e imprescindível, pelo período de dois anos, do medicamento *TERIPARATIDA 250 mcg/ml, 1 vez ao dia, 20mcg, via subcutânea, por dois anos, sob pena de " perda de densidade mineral óssea com alto risco de fraturas de fragilidade que podem gerar dor cronica, na ausência do tratamento proposto".* Afirmou que não houve o fornecimento do medicamento na via administrativa e não há possibilidade de arcar com o tratamento, haja vista o elevado custo. Teceu considerações sobre o seu direito. Liminarmente, requereu que os requeridos sejam compelidos ao fornecimento do fármaco. No mérito, a confirmação da liminar. Pugnou pela concessão da justiça gratuita. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Concedido o benefício da justiça gratuita e deferida a liminar pleiteada. Determinada a citação dos réus (evento 5, DESPADEC1).

Citado, o réu Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação (evento 15, CONT1). Preliminarmente, suscitou (i) a inépcia da petição inicial, porquanto ocorreu um pedido genérico. Após, afirmou que o medicamento pleiteado foi cadastrado no AME encontrando-se com previsão de estoque. Que, em caso de eventual condenação, seja feita utilizando-se a Denominação Comum Brasileira. (ii) inclusão da União no polo passivo, vide tema 793 do STF. No mérito, a necessidade de observância ao cumprimento dos critérios fixados pelo STJ no Tema repetitivo nº 106. Acostou nota técnica afirmando não haver recomendação para fornecimento do fármaco. Afirmou acerca da necessidade de apresentação do receituário a cada seis meses. Requereu a improcedência. Juntou documentos.

Citado, o réu Município de Alvorada apresentou contestação (evento 20, CONT1). Preliminarmente, suscitou (i) necessidade de inclusão da União, vide Tema 793 do STF, com deslocamento da competência para Justiça Federal. Teceu considerações sobre a competência do município na gestão de saúde. Esclareceu sobre a necessidade do planejamento de inserção do usuário no SUS. Afirmou que há poder discricionário da administração pública, além da necessidade de previsão orçamentária. Requereu a improcedência.

Houve réplica (evento 28, RÉPLICA1).

Parecer final pelo *Parquet*, opinando pela procedência (evento 38, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Os autos vieram conclusos para sentença.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Fundamento e decido, com base no artigo 93, IX, da Constituição Federal[1] e nos artigos 11[2] e 489, § 1º[3], ambos do Código de Processo Civil (CPC).

O julgamento antecipado do feito está autorizado, na forma do art. 355, I, do CPC.[4]

Em que pese a regularidade do feito, existe questão processual pendente que deve ser solucionada antes de dar início ao julgamento.

Do polo ativo.

Compulsando os autos, verifica-se que consta no polo ativo a Sra. CATIA SILENE GOMES.

Contudo, analisando os documentos, tenho que não há necessidade de figurar como demandante, pois somente foi declarante em relação ao comprovante de residência (evento 1, DECL3 e evento 1, END4).

Assim, na data de hoje, procedi com a exclusão.

II.1 - PRELIMINARES

Inépcia da inicial. Pedido genérico

Insurge-se o Estado do Rio Grande do Sul, em sede de contestação, requerendo o reconhecimento da inépcia da inicial, ante a presença, em tese, de pedido genérico.

O artigo 330 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de indeferimento da inicial, esclarecendo em seu parágrafo primeiro o conceito de inépcia da exordial.

> *Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:*
>
> *I - for inepta;*
>
> *II - a parte for manifestamente ilegítima;*
>
> *III - o autor carecer de interesse processual;*
>
> *IV - não atendidas as prescrições dos **arts. 106** e **321** .*
>
> *§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:*
>
> *I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;*
>
> *II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;*
>
> *III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;*
>
> *IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.*

Em análise à peça inicial e aos documentos anexos, verifico que a parte autora indicou ser portadora de *osteoporose pósmenopáusica e esclerose sistêmica*, patologia registrada junto à Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à saúde sob o *código CID10 M810 e CID10 M34,* necessitando fazer uso do medicamento *TERIPARATIDA 250 mcg/ml, 1 vez ao dia, 20mcg, via subcutânea, por dois anos (evento 1, INIC1).*

O pedido de toda medicação ou tratamento necessário contra a moléstia indicada na inicial não se configura pedido genérico, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ e TJRS:

> *PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 /CPC. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO. PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO.*
> *[...]*
> *2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que a decisão judicial que condena o **Estado** a prestar medicamento requerido na inicial, bem como outros que se fizerem necessários ao tratamento de doença específica, não se afigura incerta, tampouco advém da formulação de pedido genérico.*
> *[...]*
> *(AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015).*
>
> *APELAÇÃO. ECA. TRATAMENTO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Paciente com seis anos de idade, diagnosticada com hipertrofia das amígdalas, com hipertrofia das adenóides. Avaliação com otorrinologista e a realização de cirurgia indicada (adenoamigdalectomia + CCIS), bem como tratamento pós operatório. Ausência de pedido incerto e condenação genérica. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075698423, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 14/12/2017).*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO DE TODOS E DEVER DO **ESTADO** - ART. 196, CF. SENTENÇA ULTRA PETITA. DISPOSITIVO GENÉRICO. REJEIÇÃO. A sentença prolatada não é ultra petita, porque não condena o **Estado** ao fornecimento de exames médicos em sentido genérico, como afirma o ente público, mas sim à cirurgia postulada na inicial. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70072476435 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 09/03/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2017).*

Assim, tenho que ficaram delimitados nos autos os fatos e pedidos, o que permitiu, inclusive, que a parte ré apresentasse contestação, contrapondo os argumentos trazidos pela parte autora.

Logo, **rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada.**

Da aplicabilidade do Tema nº 793 do STF

A parte ré, Estado do Rio Grande do Sul e Município de Alvorada, requereu a observância do Tema n.º 793 do STF, com a inclusão da União no polo passivo da demanda.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever do Estado como um todo considerado, ou seja, dever de todos os seus entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), de forma solidária, a prestar o direito à saúde, inclusive, é o que se depreende do disposto no art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 793 (RE n.º 855178), fixou a seguinte tese:

> *Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da **saúde**, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.*

Sobre o assunto, transcrevo fundamentação proferida pela Desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, quando do julgamento do recurso de Apelação n.º 70084154244:

> *"[...] Ademais, não há que se falar em formação de litisconsórcio necessário com a União, tendo em vista que está apenas repassa a verba necessária ao atendimento médico, sem relação direta com o cidadão".*

Desse modo, considerando que a parte autora optou por litigar contra o estado do Rio Grande do Sul e o Município de Alvorada/RS, ambos têm, solidariamente, o dever de garantir o direito à saúde pleiteado.

Outrossim, eventual litisconsórcio seria facultativo, por opção do demandante, que escolhe contra quem demandar, tratando-se de obrigação solidária, cumprindo ressaltar que eventual procedência da ação não afetará a União, inaplicável o artigo 114 do Código de Processo Civil no presente caso, podendo a lide ser ou não decidida de modo uniforme para todas as partes.

No mesmo sentido, cito trecho da decisão do STF no julgamento do ARE n.º 1253568/SC, em 26/03/2020:

> *Ademais, como bem ressaltou o juízo de admissibilidade do presente recurso extraordinário, ao examinar o julgamento do recurso-paradigma RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, o Plenário do Tribunal reconheceu existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, **podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente**. - Grifei -*

Colaciono ainda julgados do Tribunal de Justiça Gaúcho:

> *EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO/TRATAMENTO. TEMA REPETITIVO Nº 793 DO STF. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto que justifique a interposição dos embargos declaratórios. 2. Mesmo que seja prequestionamento da matéria, devem estar presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Não é o caso dos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema repetitivo nº 793 (RE nº 855178), não criou a obrigação de se chamar a União à lide. Apenas reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Seria contraditório a Corte Suprema reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e ao mesmo tempo determinar o direcionamento da ação para a União. Vale ressaltar que cabe à União (Ministério da Saúde) formular as políticas nacionais de saúde, mas não efetuar a sua realização, ou seja, não cabe a esta o cumprimento de tais políticas, como é o caso do fornecimento de medicamentos/tratamentos de saúde. Assim, por ora permanece inalterado o entendimento de que além de não ser adequada a inclusão da União no polo passivo, eis que não existe litisconsórcio necessário, tal ato resulta em maior morosidade na solução da lide, o que não se pode admitir no caso, considerando-se a gravidade da doença que está acometida a parte autora (câncer). 4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito, assim como o Julgador não está adstrito a rebater todas as teses levantadas pelas partes, mas sim a demonstrar logicamente o caminho pelo qual chegou à conclusão (Tema 339 do STF – repercussão geral). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Cível, Nº 70084294750, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 01-07-2020).*

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. **SAÚDE**. ADULTO INCAPAZ - SÍNDROME DE DOWN. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO **ESTADO** DO RIO GRANDE DO SUL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178/SE - TEMA 793 - DO E. STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. HIPERTENSÃO PULMONAR TRAMBÓLICA CRÔNICA E EMBOLIA PULMONAR COM MENÇÃO DE COR PULMONALE AGUDO - CID 10.126.0 E 10.127.2. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RIOCIGUAT. PROBABILIDADE DO DIREITO DO RECORRIDO EVIDENCIADA. RISCO DE MORTE DECORRENTE DA EVOLUÇÃO DA MOLÉSTIA. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC DE 2015. Preliminar. Evidenciada a legitimidade passiva do **Estado** do Rio Grande do Sul, e o descabimento do litisconsórcio passivo necessário com a União, em razão da solidariedade dos Entes Públicos na prestação da saúde - art. 196 da Constituição da República -, consoante estabelecido no julgamento do RE n° 855.178/SE – Tema 793 -, do e. STF, independentemente das atribuições de cada ente público, objeto de compensações na via administrativa, consoante o art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90. Precedentes deste tribunal. Mérito. 1 -[...]. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido(Agravo de Instrumento, Nº 70082894494, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 07-05-2020).*

Ademais, conforme atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, nos processos em que se postula medicamentos não incorporados, mas registrados na ANVISA, o critério modificador da competência é o custo anual do tratamento, devido à responsabilidade solidária dos entes federados.

In casu, o medicamento postulado (Teriparatida 250mcgl/ml), o qual não se encontra na lista RENAME 2022, possui valor (tratamento anual), com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), inferior ao valor de 210 salários mínimos, não havendo que se falar na inclusão da União no polo passivo da demanda

Desse modo, **não há que se falar na inclusão da União no polo passivo da demanda**, tendo o STF reiterado que a responsabilidade dos entes públicos em matéria de saúde é solidária.

II.2 - MÉRITO

Assentada em tais premissas, estando o feito em ordem, ausentes nulidades ou irregularidades processuais a serem sanadas, passo a analisar o mérito.

Da Assistência à Saúde

Insta mencionar que em conformidade com o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, bem como de acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais pátrios, a responsabilidade dos entes federados, no tocante à saúde, é solidária e integral, podendo o cidadão dirigir a demanda contra qualquer um deles.

Cabe a União, Estados e Municípios, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à vida e saúde, fornecendo atendimento médico e tratamentos à população, bem como disponibilizando os medicamentos necessários aos que não podem adquiri-los por ausência de condições financeiras, conforme preleciona o artigo 196 da Constituição Federal:

> *Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> *Para a efetivação deste direito, determinou o art. 198 da CF/88 a formação de uma rede regionalizada e hierarquizada em um sistema único e descentralizado - Sistema Único de Saúde (SUS) -, cujas diretrizes são as seguintes:*
>
> *I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;*
>
> *II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;*
>
> *III - participação da comunidade.*

Outrossim, a Administração Pública deve se pautar pela obediência ao *Princípio da Legalidade* (à lei e ao direito), porém, sem se furtar ao cumprimento das decisões judiciais.

A independência entre os poderes, não poderá permitir violação de preceitos constitucionais e legais no exercício de suas funções (ou em sua omissão) contando, ainda, com a proteção da não intervenção do Estado-Juiz.

De tal modo, ocorrendo omissão do Poder Público no cumprimento de norma constitucional elevada à categoria de direito fundamental, compete ao Poder Judiciário ordenar que os órgãos públicos competentes adotem as medidas cabíveis a efetivação do direito.

Além disso, o direito a saúde e à vida, como princípios fundamentais, prevalecem sobre qualquer outro.

Por fim, destaco que por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 106, o STJ fixou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

> *(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
>
> *(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
>
> *(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

Da Prova da Moléstia e da Necessidade do Tratamento Postulado

A prestação jurisdicional não pode deixar de considerar a situação individualizada de cada caso.

No caso em comento, a tutela provisória foi deferida (evento 5, DESPADEC1), determinando que os entes públicos fornecessem o medicamento postulado.

Cumpre ressaltar, ainda, que o atendimento da pretensão veiculada na inicial independe de previsão orçamentária, haja vista que a Carta Magna disciplina que os direitos fundamentais devem ser tratados com prioridade não só pela família e pela sociedade, mas, também, pelo Poder Público, afastando a alegação de carência de recursos financeiros como justificativa para a omissão.

Não fosse isso, de regra, não há que se atender a estudos e sugestões de substituição dos remédios emitidos pela respectiva secretaria de saúde, em detrimento da prescrição realizada pelo médico do paciente. O escopo preponderante da administração pública, na espécie, é o barateamento do tratamento e o almejo maior do profissional que atende o enfermo é o melhor para sua saúde.

Jurisprudência amparando tal entendimento:

> *ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente*

demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

No caso dos autos, a patologia que acometeu a parte autora restou comprovada pela prova documental acostada aos autos (evento 1, LAUDO6), diagnosticada *osteoporose pósmenopáusica e esclerose sistêmica*, patologia registrada junto à Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à saúde sob o *código CID10 M810 e CID10 M34,* necessitando do tratamento solicitado, sob pena de progressão:

LAUDO MÉDICO PARA AÇÃO JUDICIAL

Medicamento(s)/Insumo(s) fora da lista do SUS ou não Fornecido para o CID do paciente

Atesto para os devidos fins que o paciente Joana Gomes Pidro, cartão SUS nº. 700907936897693 portador da(s) enfermidade(s) – informar CID(s): M810 e M34

Necessita do(s) medicamento(s)/insumo(s) (fraldas/tiras reagentes para diabéticos/ alimentação especial/curativos). Nome por extenso. Em caso de **medicamento** deve constar o nome na Denominação Comum Brasileira, bem como, da substância ativa e nome comercializado.

Teriparatida 250 mg/ml (caneta) 2,4 ml

Pelo período (determinado ou indeterminado?):

Por dois anos, 24 meses

Posologia, dosagem diária e mensal:

1 vez ao dia, 20 mcg, via subcutânea

Caso não seja administrado o medicamento ou insumo prescrito poderá ocorrer as seguintes consequência/riscos para a saúde do paciente. Constar o risco de morte **(somente se for o caso):**

Perda de densidade mineral óssea com alto risco de fraturas de fragilidade que podem gerar dor crônica.

Em caso de **URGÊNCIA** na ingesta do medicamento ou insumo prescrito, constar expressamente:

Paciente com score 2, extremamente baixo de -4,9 e 2,6 em coluna lombar, região muito predisposta a fraturas patológicas e femur.

Justificar a razão pela qual não restou prescrito remédio/insumo integrante das listas padronizadas do SUS e/ou dos Protocolos Clínicos:

Paciente com esofagopatia grave com contraindicação de uso de bisfosfonado via oral.

Jobson Martins Pereira
Médico
CRM/ES 23611

Indicar a **IMPOSSIBILIDADE DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE UM DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SUS** por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica:

Não pode consumir bifosfonados por ter esofagopatia grave, sequela de esclerose sistêmica

Explicar quais os efeitos benéficos do uso do fármaco/insumo prescrito não integrante das listas padronizadas do SUS e/ou Protocolos Clínicos.

Especificar os medicamentos/insumos integrantes das Listas e/ou Protocolos Clínicos que já foram ministrados ao paciente e não foram eficazes no combate da patologia, bem como quais efeitos colaterais produzidos no organismo do paciente.

Fazer comparação entre fármacos/insumos das(os) Listas/Protocolos Clínicos e os que não integram, apresentando Evidências Científicas e Estudos Literários atuais do fármaco/insumo prescrito que não integra as Lista/Protocolos Clínicos da rede pública, demonstrando que são mais eficazes para o controle da moléstia.

Os medicamentos citados para o CID 34, azatioprina, ciclofosfamida, metotrexate, sildenafila não revertem ou melhoram o quadro de osteoporose. Outros medicamentos usados para esse fim seria do tipo de bisfosfonados, mas eles não podem ser usados pela esofagopatia grave de mesma.

Declaro, ainda, que não possuo qualquer interesse na prescrição do medicamento que não o tratamento da saúde do paciente, bem como não mantenho qualquer vínculo com a indústria farmacêutica.

Alvorada, 12 de Maio de 23.

Assinatura (Carimbo, CRM e CPF): 68878362034

DE ACORDO (do paciente):

Hodson Martins Pereira
Médico
CREMERS 23811

A pretensão encontra respaldo nos artigos 5º, parágrafo 1º, 6º e 196, da Constituição Federal, combinados com o artigo 241, da Constituição Estadual e o artigo 1º da Lei Estadual n.º 9.908/93.

A proteção à inviolabilidade do direito à vida e saúde, deve prevalecer em detrimento a qualquer outro interesse estatal, já que sem ele os demais interesses socialmente reconhecidos não possuem o menor significado ou proveito.

Nesta seara, segue a jurisprudência:

> *APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. **SAÚDE**. FORNECIMENTO DE **MEDICAMENTO**. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DO RESP N.º 1.657.156/RJ (TEMA 106 STJ). DESCABIMENTO NA VIA ORDINÁRIA. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE FORNECER MEDICAMENTOS. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Descabe a suspensão do processo durante sua tramitação ordinária em razão da afetação do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, em se tratando de direito à **saúde**, a matéria exige urgência e brevidade no julgamento. A decisão de sobrestamento proferida pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo nº 1.657.156/RJ alcança somente os Recursos Especiais interpostos sobre o mesmo objeto. 2. O direito à **saúde** é direito de todos e dever do Estado Iato sensu, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal. 3. A distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de **Saúde**, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal. 4. A previsão orçamentária não pode limitar a atuação do Estado na efetivação dos direitos sociais e fundamentais. O direito à **saúde** está diretamente relacionado com a ideia de mínimo existencial, que constitui o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, de forma que a mera alegação da reserva do possível não constitui óbice a tutela jurisdicional de um direito fundamental. 5. Ao Poder Judiciário não cabe decretar a inadequação do fármaco recomendado pelo médico responsável pelo tratamento da autora, ainda que não conste em lista do Sistema Único de **Saúde**. O profissional da Medicina que mantém contato direto com o paciente é quem tem conhecimento e condições de avaliar e prescrever o tratamento adequado. 6. Por idênticas razões, não prospera a alegação de necessidade de esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS ou de substituição do fármaco por outros medicamentos que estejam inseridos na lista dos fornecidos pelo Poder Público. 7. O contexto probatório revela a hipossuficiência dos demandantes para arcar com os medicamentos, devendo ser fornecidos pelos Entes Públicos. Evidente que possível alteração na situação financeira dos demandantes pode ensejar a suspensão da disponibilização dos medicamentos, o que poderá ser objeto de pedido e prova perante o juízo do cumprimento da sentença. A prova atual alicerça a condenação dos entes públicos na prestação dos fármacos. 8. É devida a comprovação da necessidade dos medicamentos em periodicidade adequada que não onere os demandantes. 9. Remessa Necessária. Considerando que a decisão singular é ilíquida, aplica-se ao caso o disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil e na Súmula nº 490 do STJ. 10. O Estado fica isento do pagamento de custas processuais quanto as serventias estatizadas, nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Lei 8.121/85. 11. É devido pelo ente municipal o pagamento das custas processuais por metade em face da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.471/2010, o que impõe a aplicação da redação originária do art. 11 da Lei Estadual nº 8.121/1985. APELAÇÃO DOS DEMANDADOS DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS DEMANDANTES PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078298650, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 08/08/2018).*

Assim, diante das alegações médicas, entendo que a não concessão da medicação postulada atentaria diretamente contra o direito constitucionalmente garantido à saúde, enquanto, devido a impedimentos de ordem administrativa, a parte autora teria prejudicada de forma considerável a possibilidade de diminuição dos efeitos decorrentes de sua enfermidade.

Ademais, não há motivos para desacreditar no diagnóstico e prescrição do fármaco, segundo atestado pelo médico assistente da parte autora, quem, justamente por esta circunstância fundamental, detém as melhores condições de avaliá-la e indicar tratamento, prevalecendo sobre a Nota Técnica nº7588 (evento 15, LAUDO2).

Além disso, foi justificado o motivo pelo qual não foi prescrito fármaco integrante das listas do SUS, qual seja, a esofagopatia grave que acomete a paciente e impossibilita o uso outros medicamentos.

O Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação (evento 38, PROMOÇÃO1).

Diante disso, resta evidente a necessidade da parte autora em receber o tratamento pleiteado, haja vista que é indispensável à manutenção de sua saúde.

Do Registro do Fármaco na ANVISA

No tocante ao registro do medicamento perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, verifica-se sua existência sob o registro nº 112600079, conforme consulte ao site[1]:

Resultado da Consulta de Produtos

	Nome do Produto	Complemento da Marca	Tipo de Regularização	Princípio Ativo ou Descrição do Medicamento Notificado	Número da Regularização	Número do Processo	Empresa Detentora da Regularização	Situação da Regularização	Vencimento da Regularização
☐	FORTEO	COLTER PEN	REGISTRADO	TERIPARATIDA	112600079	25351.178460/2002-63	ELI LILLY DO BRASIL LTDA - 43.940.618/0001-44	Ativo	03/2028
☐	FORTEO	COLTER PEN	REGISTRADO	TERIPARATIDA	112600079	25351.178460/2002-63	ELI LILLY DO BRASIL LTDA - 43.940.618/0001-44	Ativo	03/2028

Exportar para Excel Voltar

Da (in)capacidade financeira

Restou positivada a incapacidade financeira da parte autora para pagamento do tratamento, haja vista postulação do benefício da gratuidade judiciária, já concedida (evento 5, DESPADEC1) e pela fruição dos serviços prestados pela Defensoria Pública.

O pedido veio acompanhado de laudo médico no evento 1, LAUDO6 que demonstra a necessidade do insumo postulado.

Ademais, a ausência de fornecimento de insumos necessários para manutenção dos cuidados do paciente poderá lhe causar danos imediatos.

O orçamento foi juntado (evento 1, OUT8).

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Alvorada, tendo em vista a relevância pública do direito à saúde.

Da Denominação Comum Brasileira

Imperioso destacar que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reconhece a possibilidade de substituição do fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira, que possuem o mesmo princípio ativo. Neste sentido: Apelação Cível, N.º 70084379239, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-07-2020.

No caso em análise, o medicamento foi postulado na inicial pelo nome do princípio ativo *TERIPARATIDA 250 mcg/ml.*

Assim, o fármaco deve ser disponibilizado conforme a denominação comum brasileira.

Das Verbas Honorárias

No que se refere a possibilidade de condenação do Estado em honorários, quando a parte vencedora for representada pela Defensoria Pública, necessário atentar-se ao Tema 1002 do STF.

Em 26/06/2023, a Corte Suprema julgou o RE nº 1140005 pelo rito dos recursos repetitivos (**Tema nº 1002**), e definiu o seguinte:

> *Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: "**1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele***

que integra; *2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.*

Além disso, em razão da decisão, houve revogação da súmula 421 do STJ[2].

Logo, além do Município, o Estado também é responsável pelo pagamento de honorários à Defensoria Pública, sendo plenamente cabível a fixação.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no Art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **JOANA GOMES PIUCCO** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** e do **MUNICÍPIO DE ALVORADA**, para determinar que os requeridos forneçam gratuitamente à parte autora o medicamento *TERIPARATIDA 250 mcg/ml, 1 vez ao dia, 20mcg, via subcutânea, por dois anos,* enquanto necessário e conforme prescrição médica, admitida a dispensação pela denominação comum brasileira. A necessidade do medicamento poderá ser reavaliada a cada seis meses, mediante a apresentação de atestados médicos que justifiquem o prosseguimento do tratamento.

Condeno cada réu ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, com base no artigo 85, parágrafo 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Os requeridos são isentos do pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 5º, I, da Lei Estadual n.º 14.634/2014.

Imperiosa a Remessa Necessária do feito, por se tratar de sentença ilíquida, hipótese descrita no enunciado da Súmula n.º 490 do STJ, estando sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com baixa.

Registro e publicação pelo sistema. Intimação eletrônica agendada.

Documento assinado eletronicamente por **LIVIA DA COSTA BRAGANCA, Juíza Substituta**, em 24/11/2024, às 20:40:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10069742175v14** e o código CRC **15c0f5b8**.

---

1. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:[...]IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...] ↩

2. Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. ↩

3. Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.[...] ↩

4. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver necessidade de produção de outras provas; [...] ↩

1. https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?numeroRegistro=112600079 ↩

2. https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/22042024-Corte-Especial-cancela-sumula-sobre-honorarios-advocaticios-da-Defensoria-Publica.aspx ↩